

Manual de funciones del servicio de fisioterapia

Manual | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Delimitar las funciones asistenciales y administrativas, los límites de delegación y las responsabilidades frente al paciente.

2. Alcance y condiciones de uso

Adaptar a independiente o IPS y a los apoyos reales. El titular puede acumular funciones compatibles pero debe identificar su responsabilidad en cada registro.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Titular o dirección	Verificar autorización, vínculo y competencia antes de asignar.
Fisioterapeuta	Trabajar dentro de competencia, actualizarse y pedir apoyo.
Apoyo administrativo	Custodiar expediente laboral y no realizar intervención clínica.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. El fisioterapeuta realiza valoración integral, diagnóstico fisioterapéutico, objetivos, in

El fisioterapeuta realiza valoración integral, diagnóstico fisioterapéutico, objetivos, intervención, seguimiento y egreso; solicita apoyo cuando el caso excede sus competencias y no garantiza resultados de curación.

2. El responsable del servicio controla portafolio, recursos, riesgos y calidad

El responsable del servicio controla portafolio, recursos, riesgos y calidad. Verifica que equipos y espacios sean seguros y que haya rutas de comunicación para emergencias y derivación.

3. El apoyo administrativo verifica citas e identificación sin acceso indiscriminado a notas

El apoyo administrativo verifica citas e identificación sin acceso indiscriminado a notas clínicas. Solo consulta los datos necesarios y usa canales autorizados; no interpreta diagnósticos ni entrega historias a terceros sin legitimación.

4. El ejecutor de limpieza sigue fichas de productos, protección y frecuencias; registra lo r

El ejecutor de limpieza sigue fichas de productos, protección y frecuencias; registra lo realizado y comunica omisiones o daños. No libera material estéril sin formación y autoridad técnica específicas.

5. El responsable de dispositivos controla inventario, fichas, mantenimiento y alertas

El responsable de dispositivos controla inventario, fichas, mantenimiento y alertas. Retira equipos sospechosos y evita liberarlos por decisión administrativa sin comprobación técnica.

6. El responsable de archivo controla acceso, autenticación, entrega y respaldos

El responsable de archivo controla acceso, autenticación, entrega y respaldos. Documenta sustitución y continuidad por ausencias; informa al equipo y actualiza perfiles sin inventar personas.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Cada actividad tiene responsable identificable.

Acceso por necesidad funcional.

Evaluación de funciones al menos anual como regla local.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.1 y 11.3.1.1-5: talento humano, título y formación según oferta. Para integración neurosensorial, numeral 1.2 específico; verificar condiciones de la modalidad.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Rol	
Actividad asignada	
Límite de delegación	
Competencia requerida	
Recurso de trabajo	
Registro generado	
Responsable real	
Contingencia de ausencia	
Fecha de revisión	
Evidencia de socialización	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576